

Lo que solo el hogar sabe · Documentos de trabajo · Documento DT-02
Borrador para comentarios. No citar sin contrastar.

El trámite como barrera

La única razón de no consulta que crece de forma sostenida en Colombia, 2012–2025, y por qué su gradiente parece invertido

Daniel A. Garavito Jiménez

Economista de la salud. Ex asesor de Innovación y Analítica, ADRES.

Procesamiento propio de los microdatos anonimizados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE).
Septiembre de 2026

Versión 1.0 · 12 de septiembre de 2026 · Cítese la versión. Las correcciones posteriores a la publicación quedan con fecha en la fe de erratas: datos.sinergistica.com/erratas.html

Resumen

Entre las personas que tuvieron un problema de salud y no recibieron atención médica, la proporción que lo atribuye a trámites o a falta de autorización pasó de 3,9% en el nivel prepandémico a 6,5% en 2025 (IC 95%: 4,5–9,1), una diferencia de +2,6 puntos porcentuales ($p = 0,0306$).

De las cinco razones de no consulta que la encuesta distingue, esta es la única con una pendiente que se distingue de cero en el diseño muestral vigente: +0,436 puntos por año (EE 0,078; $t(4) = 5,64$; $p = 0,0049$; $R^2 = 0,888$). Ni la financiera, ni la geográfica, ni la de oferta muestran deriva. Mientras la barrera del dinero cede y la afiliación se universaliza, la del procedimiento crece.

El indicador es más frecuente en cabecera que en zona rural y entre quienes no se reconocen en un grupo étnico, y su índice de concentración de Erreygers es 0,023, levemente concentrado en los hogares de mayor ingreso. El documento argumenta que ese perfil no indica que el trámite golpee a los acomodados sino que es la firma de una cola: solo reporta trámite quien llegó hasta la ventanilla. El indicador es, por construcción, un piso.

La Resolución 2117 de 2025 adoptó el Modelo de Gestión de Tiempos de Espera y la Circular Externa 038 lo puso a operar: ambos miden el tiempo de espera de quien consiguió la cita, desde el reporte de los actores regulados. Este documento entrega la medida complementaria —quien no llegó a tenerla— y un insumo poblacional para el elemento de accesibilidad del artículo 6 de la Ley Estatutaria, no para la prohibición del artículo 14, que se refiere a la atención de urgencia.

Palabras clave

barreras de acceso; autorización administrativa; necesidad no satisfecha; EU-SILC; ENCV; SGSSS; Ley Estatutaria 1751 de 2015

1. El problema

El 16 de octubre de 2025 el Ministerio de Salud adoptó, mediante la Resolución 2117, el Modelo de Gestión de Tiempos de Espera, y el 12 de diciembre lo puso a operar con la Circular Externa 038, que fija por primera vez estándares de referencia para la asignación de citas: tres días en medicina general, cinco en pediatría, ocho en obstetricia, diez en ginecología, psiquiatría y cirugía general, quince en medicina interna. La primera fase dura seis meses y su objetivo declarado es *construir la línea de base*. La medición la reportan las EPS, las entidades adaptadas, las secretarías de salud y los prestadores: es decir, los mismos actores a quienes el estándar regula.

Ese modelo mide el tiempo de quien consiguió la cita. No mide a quien la pidió y desistió. Y en el sistema colombiano existe una forma específica de desistimiento que ninguna estadística de oferta puede capturar: la persona que no consultó *porque los trámites eran demasiados o porque no le autorizaron la atención*. Este documento estima esa barrera desde el hogar, muestra que es la única de las cinco razones de no consulta con una tendencia creciente que se distingue de cero, y argumenta que su gradiente aparentemente invertido —más frecuente entre los urbanos y los no indígenas— no es una anomalía sino la firma de una cola.

El hallazgo. Entre quienes tuvieron un problema de salud y no recibieron atención, el 6,5% lo atribuyó a trámites o a falta de autorización en 2025 (IC 95%: 4,5–9,1), frente a 3,9% en el nivel prepandémico: +2,6 puntos, $p = 0,0306$. Es la única de las cinco razones de no consulta con pendiente significativa en el diseño muestral vigente: +0,436 puntos porcentuales por año (EE 0,078; $t(4) = 5,64$; $p = 0,0049$; $R^2 = 0,888$). Ninguna otra barrera —ni la financiera, ni la geográfica, ni la de oferta— muestra deriva alguna.

2. Marco: la barrera que Europa dejó de medir

El indicador internacional de referencia para el acceso desde encuestas de hogares es la *necesidad de atención médica no satisfecha* de EU-SILC. Su lógica es condicional en dos etapas: primero se pregunta si la persona necesitó atención, luego si la recibió y, si no, por qué. Esa segunda pregunta —la razón— es la que convierte un indicador de acceso en un diagnóstico de política, porque distingue una falla de financiación de una de oferta o de localización.

En su revisión de 2015 EU-SILC colapsó las razones en una categoría agregada de «costo, distancia o lista de espera» y dejó de preguntar por autorización administrativa. La razón es comprensible: en sistemas de aseguramiento único o de servicio nacional de salud, la autorización previa no es un paso frecuente para la consulta ambulatoria. En Colombia sí lo es. El SGSSS opera con un asegurador que autoriza y un prestador que atiende, y entre uno y otro existe un procedimiento que el usuario debe atravesar. La ENCV, al conservar trece categorías de razón de no consulta, mantiene separadas dos de ellas —«muchos trámites para la cita» y «no le cubrían o no le autorizaron la atención»— que juntas describen exactamente esa fricción.

El resultado es una medición que Europa perdió y que Colombia tiene. Eso importa por dos motivos. El primero es analítico: la barrera administrativa es de naturaleza distinta a la financiera o la geográfica, porque no depende de la escasez de recursos ni de la ausencia de oferta sino del diseño del procedimiento. El segundo es normativo, y conviene enunciarlo con más cuidado del que suele usarse. El artículo 6 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 incluye la accesibilidad entre los elementos esenciales del derecho y la entiende como acceso sin barreras, físicas, económicas o de información. El artículo 14 es más estrecho de lo que la cita corriente sugiere: prohíbe exigir autorización administrativa *entre el prestador de servicios y la entidad que cumpla la función de gestión de servicios de salud y cuando se trate de atención de urgencia*. No es una prohibición general de la autorización previa, y no cubre la consulta ambulatoria ordinaria, que es lo que este indicador mide. La barrera estimada aquí no es, entonces, evidencia de incumplimiento del artículo 14; es evidencia sobre la accesibilidad del artículo 6, que es una obligación de resultado y no una prohibición puntual. La distinción decide qué se puede afirmar con el dato: que el procedimiento está expulsando personas del sistema, sí; que alguien infringe una norma específica, no.

3. Datos y método

3.1 Construcción del indicador

La ENCV pregunta, a quien tuvo un problema de salud en los últimos treinta días y no recibió atención médica, cuál fue la razón principal (P6153). La barrera de trámite agrupa dos códigos: «muchos trámites para la cita» y «no le cubrían o no le autorizaron la atención». El denominador son **las personas que no recibieron atención teniendo un problema de salud**: 3.144 observaciones sin ponderar en 2025.

Ese denominador condicional es el correcto para la pregunta «entre quienes desistieron, ¿por qué?», pero no debe leerse como una tasa poblacional. Para pasar a tasa entre quienes tuvieron necesidad hay que multiplicar por la necesidad no satisfecha: el 6,5% de trámite sobre el 35,9% de necesidad insatisfecha equivale a **2,32%** de todas las personas que reportaron un problema de salud en 2025, frente a 1,48% en el nivel prepandémico. Las dos lecturas son válidas y miden cosas distintas; confundirlas es el error más común con este tipo de indicador.

Una advertencia de comparabilidad interna: las opciones 10, 11 y 12 de P6153 solo existen desde 2014, de modo que el desglose de 2012 y 2013 no es estrictamente comparable con el resto. El código 10 —«no le autorizaron la atención»— es una de las dos que componen este indicador. Por eso las dos primeras rondas se muestran pero no entran en ninguna estimación de tendencia, que en todo caso se ajusta solo dentro del diseño vigente.

3.2 Estimación e inferencia

Los errores estándar se obtienen por linealización de Taylor sobre el diseño bietápico, estratificado y por conglomerados de la encuesta, con las variables de diseño disponibles en el microdato de 2022, 2024 y 2025 y una corrección declarada por indicador en los demás años. Los intervalos son logit (Korn y Graubard, 1998). El efecto de diseño de este indicador en 2025 es **6,80** —el más alto de las cinco razones—, de modo que las 3.144 observaciones equivalen a **462** bajo muestreo aleatorio simple. Es un indicador poco preciso y hay que decirlo: su coeficiente de variación en 2025 es 0,177.

La tendencia es una regresión por mínimos cuadrados ordinarios de la proporción anual contra el año, ajustada solo dentro del diseño vigente y excluyendo 2020 y 2021. Trata cada estimación anual como si no tuviera error de muestreo; incorporarlo por mínimos cuadrados ponderados ampliaría algo el error estándar de la pendiente. Con seis observaciones anuales la potencia es baja, lo que hace más notable que esta pendiente —y solo esta— alcance significancia.

4. Resultados

4.1 La única barrera con deriva

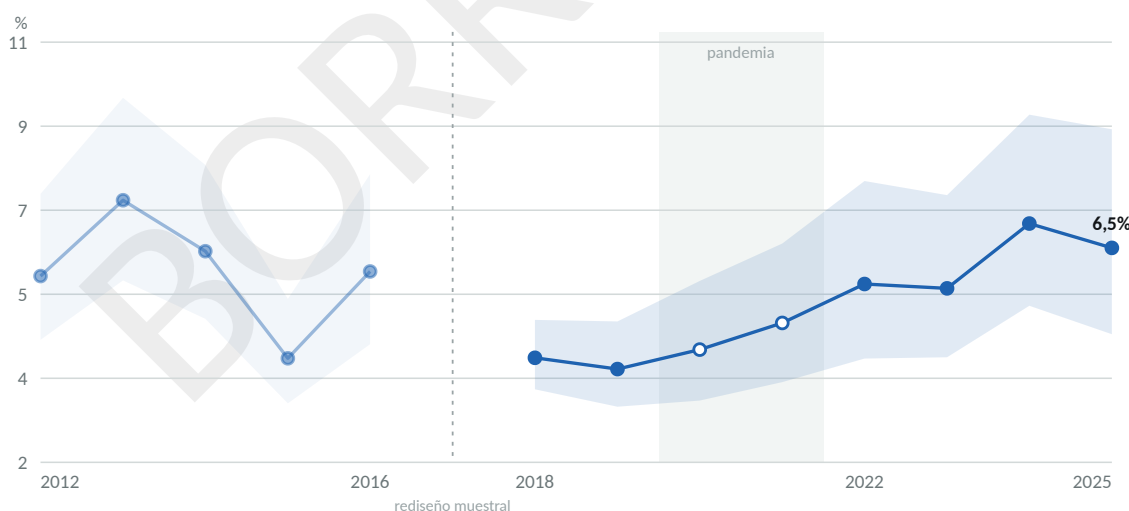


Figura 1. Barrera de trámite o autorización entre quienes no recibieron atención, 2012–2025. Banda: IC 95% en escala logit. Tramo atenuado: diseño muestral anterior a 2018, no comparable. Franja gris: rondas de pandemia. La recta continua es la regresión del tramo vigente sin años de pandemia; se dibuja continua porque su pendiente se distingue de cero. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV-DANE.

Ronda	$\hat{p}$ (%)	EE (pp)	IC 95%	CV	n	deff	n_{ef}
2012	5,83	0,82	4,4–7,7	0,140	1.905	2,32	821
2013	7,52	1,03	5,7–9,8	0,136	2.003	3,03	662
2014	6,38	0,86	4,9–8,3	0,135	1.858	2,32	802
2015	4,01	0,59	3,0–5,3	0,146	2.038	1,81	1.125
2016	5,93	0,95	4,3–8,1	0,160	1.401	2,27	618
2018	4,02	0,39	3,3–4,9	0,097	8.063	3,19	2.525
2019	3,77	0,48	2,9–4,8	0,127	5.915	3,73	1.587
2020	4,20	0,67	3,1–5,7	0,159	2.889	3,20	902
2021	4,79	0,77	3,5–6,6	0,162	2.005	2,63	761
2022	5,66	0,99	4,0–7,9	0,175	1.960	3,59	546
2023	5,56	0,91	4,0–7,6	0,163	2.162	3,37	641
2024	7,00	1,07	5,2–9,4	0,153	2.640	4,64	569
2025	6,46	1,14	4,5–9,1	0,177	3.144	6,80	462

Cuadro 1. Serie del indicador con su incertidumbre. Obsérvese el salto del efecto de diseño con el rediseño muestral de 2018 y la caída del tamaño efectivo de muestra: el indicador se estima sobre un subconjunto pequeño y muy conglomerado, y por eso sus intervalos son anchos. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV–DANE.

El contraste con las demás razones de no consulta es lo que hace del resultado algo más que un dato. El cuadro 2 estima la misma regresión para las cinco: la barrera de trámite es la única cuya pendiente se distingue de cero, y lo hace con holgura.

Razón de no consulta	2025 (%)	vs. prep. (pp)	p	Pendiente (pp/año)	EE	t(4)	p	R ²
Trámite o autorización	6,5	+2,6	0,0306	+0,436	0,078	5,64	0,0049	0,888
Oferta del prestador	11,8	+1,2	0,4519	+0,538	0,389	1,38	0,2389	0,323
Todas las del sistema	28,1	+2,3	0,2756	+0,672	0,400	1,68	0,1683	0,414
Geográfica	5,9	+0,3	0,6225	–0,129	0,149	–0,87	0,4334	0,159
Financiera	3,9	–1,8	0,0975	–0,174	0,188	–0,93	0,4073	0,176

Cuadro 2. Las cinco razones de no consulta: nivel de 2025, diferencia contra el nivel prepandémico y regresión de tendencia del tramo vigente (2018–2025, sin años de pandemia, seis observaciones anuales). Solo la fila resaltada alcanza $p < 0,05$ en la pendiente. «Todas las del sistema» agrupa las razones imputables al sistema y contiene a las demás. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV–DANE.

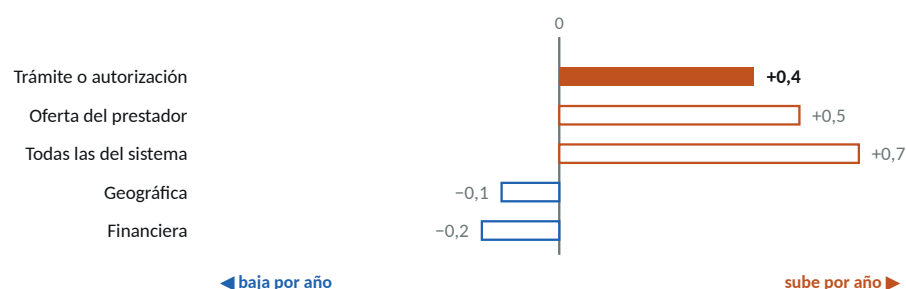


Figura 2. Pendiente anual de cada razón de no consulta, tramo 2018–2025 sin años de pandemia. Barra llena: la pendiente se distingue de cero al 5%. Solo la barrera de trámite lo hace. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV–DANE.

4.2 Quién la reporta, y por qué eso no es lo que parece

La barrera de trámite tiene un perfil demográfico nítido. Está prácticamente ausente entre los menores —2,0% en los niños de 0 a 9 años y 1,2% entre 10 y 19— y se concentra en las edades laborales: el promedio de los tres grupos entre 30 y 59 años es 9,8%, 8,2 puntos por encima del promedio de los dos grupos de menores (EE 2,45; $z = 3,35$; $p = 0,0008$).

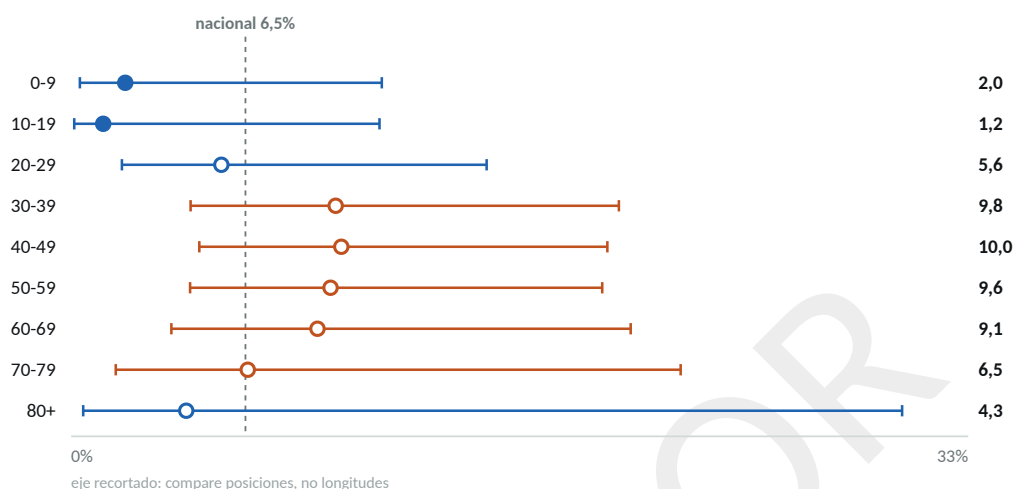


Figura 3. Barrera de trámite por grupo de edad, 2025. Punto lleno: el contraste contra el resto del país alcanza $p < 0,05$. Los intervalos son anchos porque cada grupo tiene entre 120 y 450 observaciones. Eje recortado. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV-DANE.

Y tiene un gradiente que, leído ingenuamente, resulta desconcertante: es **más** frecuente en cabecera (7,7%) que en centro poblado y rural disperso (3,0%), con una diferencia de 4,7 puntos ($p = 0,0292$), y más frecuente entre quienes *no* se reconocen en un grupo étnico (7,0%) que entre quienes sí (3,0%, $p = 0,0507$). El índice de concentración de Erreygers es **0,023**: levemente positivo, es decir, concentrado en los hogares de mayor ingreso. Es el único indicador de barrera de la encuesta con ese signo.



Figura 4. Barrera de trámite por clase, 2025. El contraste por clase es exacto bajo el diseño, que estratifica por departamento y clase. Eje recortado. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV-DANE.

4.3 La firma de una cola

La lectura ingenua de esas tres regularidades sería que el trámite golpea más a los urbanos, a los adultos y a los ricos. La lectura correcta es la contraria, y se sigue de la estructura de la pregunta. El indicador se calcula *entre quienes no recibieron atención*, y esas personas se reparten la totalidad de las razones: si crece una, las demás bajan mecánicamente. Solo reporta «trámite» quien llegó lo bastante lejos como para toparse con el trámite.

Un niño de siete años en un centro poblado cuyo hogar no consultó porque el centro de atención queda lejos nunca llega a la ventanilla de autorización. Su hogar reporta «distancia», no «trámite». Que la barrera geográfica tenga un índice de Erreygers de $-0,109$ —fuertemente concentrada en los pobres— y la de trámite 0,023 no describe dos poblaciones con problemas distintos: describe **dos estaciones distintas del mismo recorrido**. Quien es filtrado temprano no aparece en el filtro tardío.

De ahí se siguen dos consecuencias. La primera es que este indicador es un **piso**, no una medida de la carga administrativa real: no cuenta a quien consiguió la cita después de mucho trámite —esa

persona sí recibió atención y sale del denominador—, ni a quien nunca llegó a solicitarla. La segunda es que su crecimiento sostenido tiene una interpretación incómoda pero directa: a medida que la afiliación se universaliza y las barreras de entrada más gruesas ceden, más gente llega hasta la ventanilla, y la ventanilla se vuelve el cuello de botella visible.

5. Interpretación

Colombia lleva una década resolviendo el problema del carnet. La afiliación pasó de 90,6% en 2012 a 97,2% en 2025, con una pendiente de +0,60 puntos por año que se distingue de cero con holgura. En el mismo periodo la barrera financiera de acceso cayó —3,9% en 2025, 1,8 puntos por debajo del nivel prepandémico— y la geográfica se mantuvo estable. La barrera que crece no es la del dinero ni la de la distancia: es la del procedimiento.

Eso no es una paradoja sino una secuencia previsible. Un sistema que expande cobertura sin expandir capacidad de gestión traslada la restricción hacia adentro: del acceso al aseguramiento, al acceso al servicio. La literatura de sistemas de salud lo describe como el paso de la cobertura nominal a la cobertura efectiva, y es la brecha que la Ley Estatutaria intentó cerrar por vía de principio —la accesibilidad del artículo 6— sin que el principio se haya traducido en el dato. La vía normativa puntual no alcanza aquí: la prohibición del artículo 14 está circunscrita a la atención de urgencia y a la relación entre prestador y gestor.

Con todo, hay que ser preciso sobre lo que la encuesta no dice. No dice que el número de trámites haya aumentado, ni que las EPS estén negando más autorizaciones. Dice que *una proporción creciente de las personas que desistieron de consultar atribuye su desistimiento al trámite*. Esa proporción puede crecer porque el trámite empeora, porque las otras barreras mejoran, o porque cambia la composición de quienes desisten. Las tres explicaciones son compatibles con el dato; la ENCV, al ser un corte transversal repetido y no un panel, no las separa. Distinguir las exige triangular con la serie compuesta —el 2,32% sobre el total de personas con problema de salud, que también subió— y con fuentes administrativas de negación de autorización.

6. Límites

Precisión baja. El coeficiente de variación de 0,177 y el intervalo de 4,5–9,1 son amplios. La estimación del nivel de un año concreto debe citarse con su intervalo. Lo que sí es robusto es la *tendencia*: seis puntos anuales alineados con R^2 de 0,888 son difíciles de producir por azar, y ese es el resultado que este documento defiende.

Denominador condicional. El indicador no es una tasa poblacional y no debe citarse como tal. La sección 3.1 da la conversión.

Es un piso. Quien atravesó el trámite y consiguió la cita no aparece. La carga administrativa real es mayor que la que este número mide, en una magnitud que la encuesta no permite estimar.

Autorreporte de la razón principal. La pregunta admite una sola razón. Un hogar que enfrenta a la vez distancia y trámite escoge una. Eso deprime todas las categorías de forma desigual y hace que las comparaciones entre razones sean menos limpias que las comparaciones de una razón consigo misma a lo largo del tiempo, que es la comparación que este documento usa.

Cambio de opciones en 2014. Una de las dos categorías que componen el indicador no existía en 2012 y 2013. Ninguna tendencia se ajusta sobre esos años.

7. Implicaciones de política

Primero: el Modelo de Gestión de Tiempos de Espera necesita un denominador que no tiene. El modelo de la Resolución 2117 mide el tiempo hasta la cita asignada. Este indicador mide a quien no llegó a tener cita. Publicar el primero sin el segundo produce una estadística que mejora cuando el sistema empeora: si más gente desiste, la cola de los que quedan se acorta. Cruzar ambos es la única

forma de leer el modelo sin ese sesgo, y la ENCV lo permite con periodicidad anual y representatividad departamental.

Segundo: la accesibilidad tiene una medida poblacional y no se está usando. El artículo 7 de la Ley Estatutaria ordena divulgar anualmente evaluaciones sobre el goce efectivo del derecho, y la accesibilidad del artículo 6 es uno de los elementos que esa evaluación debe cubrir. Esta serie aporta para ese elemento lo que las fuentes administrativas no pueden aportar: una medida construida desde el hogar, independiente del regulado, con trece rondas de historia y representatividad departamental. No resuelve el cumplimiento del artículo 14 —que, como se argumentó en la sección 2, regula otra cosa— pero cubre un vacío que el propio Ministerio reconoce.

Tercero: la comparación internacional es una posición, no una limitación. Que EU-SILC haya perdido esta categoría en 2015 significa que Colombia mide algo que los países de referencia no miden. Documentar la serie con estándar metodológico es la vía para que la categoría vuelva a las discusiones comparadas, no para excusarse de no poder compararla.

Cuarto: hace falta preguntar por el trámite superado. Un ítem adicional —«¿cuántas veces tuvo que volver o gestionar antes de conseguir la cita?»— aplicado a quienes sí se atendieron convertiría un indicador de desistimiento en una medida de carga administrativa. Es la brecha que hoy queda entre lo que la encuesta mide y lo que la política necesita.

·. Referencias

- Berwick, D. M., Nolan, T. W., y Whittington, J. (2008). The Triple Aim: Care, health, and cost. *Health Affairs*, 27(3), 759–769.
- Congreso de Colombia. (2011). *Ley 1438 de 2011*, artículo 3. Diario Oficial 47.957.
- Congreso de Colombia. (2015). *Ley Estatutaria 1751 de 2015*, artículos 6, 7 y 14. Diario Oficial 49.427.
- Defensoría del Pueblo. (2025, 5 de noviembre). *Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados*. Bogotá.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). *Boletín técnico: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025*. Bogotá: DANE.
- Erreygers, G. (2009). Correcting the concentration index. *Journal of Health Economics*, 28(2), 504–515.
- Eurostat. (2018). *Methodological guidelines and description of EU-SILC target variables: unmet need for medical examination*. Luxemburgo.
- Korn, E. L., y Graubard, B. I. (1998). Confidence intervals for proportions with small expected number of positive counts estimated from survey data. *Survey Methodology*, 24(2), 193–201.
- Lumley, T. (2010). *Complex surveys: A guide to analysis using R*. Hoboken: Wiley.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2025, 12 de diciembre). *Circular Externa 038 de 2025*, Modelo de Gestión de Tiempos de Espera. Bogotá.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2025, 16 de octubre). *Resolución 2117 de 2025*, por la cual se adopta el Modelo de Gestión de Tiempos de Espera para la atención en salud. Bogotá.
- Nundy, S., Cooper, L. A., y Mate, K. S. (2022). The Quintuple Aim for health care improvement. *JAMA*, 327(6), 521–522.
- Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial. (2023). *Tracking universal health coverage: 2023 global monitoring report*. Ginebra.

Descargo. Las opiniones, análisis y propuestas de este documento son exclusivamente del autor, a título personal. No comprometen a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), al Ministerio de Salud y Protección Social, ni a ninguna otra entidad del sector. El trabajo se elabora íntegramente a partir de fuentes de acceso público: microdatos anonimizados del DANE, normatividad publicada, informes oficiales y bases de datos internacionales abiertas. No emplea información reservada, datos personales de beneficiarios ni información de operación contractual. Las propuestas son hipótesis de discusión, no compromisos institucionales.

Serie «Lo que solo el hogar sabe · Documentos de trabajo». El código de procesamiento, el catálogo de campos y las verificaciones contra los boletines oficiales son reproducibles. Cualquier error es responsabilidad del autor.